

Résumé : Malvoyance chez l'Enfant

****Dr Hassairi Asma****

1. Définitions (selon l'OMS)

L'OMS classe les déficiences visuelles selon deux critères de performance visuelle :

| Critère | Description | Seuil pathologique |

|---|---|---|

| ****Acuité visuelle (AV)**** | Capacité à voir distinctement les détails à une distance donnée | $AV < 3/10$ avec correction optique |

| ****Champ visuel**** | Étendue de la vision autour de l'objet fixé (normalement $180^\circ \times 130^\circ$) | Réduction significative |

- ****Malvoyance**** : déficience visuelle avec vision fonctionnelle **réadaptable**.
- La déficience entraîne une incapacité à effectuer certaines tâches, mais deux personnes avec la même déficience peuvent avoir des comportements très différents selon leur utilisation de la vision fonctionnelle.
- Une ****réadaptation**** est nécessaire pour optimiser l'utilisation de la vision résiduelle et des sens compensatoires.

2. Causes de malvoyance chez l'enfant

2.1 Glaucome congénital

- Anomalie du développement de l'angle irido-cornéen empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse.
- ****1ère cause de cécité infantile en Tunisie****.
- Souvent bilatéral, présent à la naissance ; héréditaire dans 50 % des cas.

****Signes cliniques : ****

- Larmoiement clair, photophobie, cornée trouble
- Mégalocornée (diamètre cornéen augmenté — "enfants aux trop beaux yeux")
- Antécédents familiaux

****Diagnostic : **** examen sous anesthésie générale (AG) avec mesure du tonus oculaire.

****Évolution sans traitement : ****

- Cécité par atrophie optique
- Buphtalmie (augmentation du volume du globe)

2.2 Cataracte congénitale

- Opacités cristalliniennes constatées à la naissance ou apparaissant plus tard.
- ****2ème cause de cécité chez l'enfant tunisien****.
- Trouble visuel constant ; ****leucocorie**** (pupille blanche) = signe de découverte le plus fréquent.

2.3 Rétinoblastome

- Tumeur maligne primitive de la rétine, la plus fréquente chez l'enfant (nourrisson / jeune enfant).
- Signe d'appel principal : ****leucocorie**** (pupille jaune).
- Diagnostic précoce indispensable pour améliorer le pronostic vital et fonctionnel.

2.4 Rétinopathie pigmentaire

- Ensemble de dystrophies rétiniennes héréditaires.
- Atteinte du couple photorécepteur-épithélium pigmentaire (EP).
- Destruction progressive des photorécepteurs → remaniements de l'EP → amas pigmentés rétinien.

2.5 Syndrome d'Usher

- Affection génétique rare (~1/25 000 naissances).
- Association : perte d'audition + perte de vision progressive.

2.6 Maladie de Stargardt (dystrophie maculaire juvénile)

- Dystrophie maculaire juvénile la plus fréquente (prévalence : 1/10 000).
- Accumulation anormale de ****lipofuscine**** dans les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien.
- Transmission autosomique récessive.

2.7 Malformations congénitales

2.8 Forte myopie

2.9 Amblyopie

- Trouble du développement du système visuel (rétine + cortex strié et extrastrié).
- Se manifeste par une AV anormalement basse d'un ou des deux yeux, et de nombreuses autres anomalies de la fonction visuelle.

2.10 Rétinopathie du prématuré (RDP)

- Trouble prolifératif touchant les vaisseaux rétinien en développement chez le prématuré.
- La vascularisation rétinienne débute vers la 16ème semaine et se complète vers la 40ème semaine.
- Peut entraîner une mauvaise acuité visuelle ou la cécité.

2.11 Dystrophies cornéennes

- Altérations cornéennes primaires, bilatérales et génétiques.
- Toutes autosomiques dominantes (AD) sauf la forme maculaire (récessive).
- Apparaissent dans les premières décennies de vie, stables ou lentement progressives.

| Catégorie | Exemples |

|---|---|

| ****Épithéliales**** | Dystrophie de la membrane basale, Meesmann, Reis-Bückler |

| ****Stromales**** | Granulaire, Lattice, Maculaire |

| ****Endothéliales**** | Dystrophie de Fuchs |

2.12 Albinisme

- Maladie génétique incurable due à une anomalie héréditaire de la ****mélanine****.
- Absence partielle ou totale de mélanine → dépigmentation des cheveux, ongles, yeux, peau.
- Conséquences : AV de mauvaise qualité, fragilité cutanée à l'exposition solaire (risque de cancer).

2.13 Malvoyance d'origine centrale (CVI - Cerebral Visual

Impairment)

- Troubles visuels chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, extrêmement variés.
- La CVI a remplacé la cataracte congénitale et la RDP comme ****principale cause de malvoyance**** dans les pays développés, grâce aux progrès de la réanimation néonatale.

3. Prise en charge

3.1 Volet médical

- Dépistage précoce par le pédiatre, la puéricultrice, ou dès la maternité.
- Les parents sont souvent à l'origine de la première consultation ophtalmologique.
- ****Règle clé**** : plus le diagnostic est précoce, meilleure est la prise en charge.
- Bilan ophtalmologique + examens complémentaires : échographie, électrophysiologie visuelle, examen sous AG.

3.2 Prise en charge multidisciplinaire

L'équipe comprend :

- Ophtalmologiste, puéricultrice, pédiatre, psychiatre, psychologue, assistante sociale
- ****Orthoptiste****
- Instructeur en locomotion, psychomotricien, ergothérapeute, orthophoniste
- Educateur spécialisé, pédagogue itinérant spécialisé en déficience visuelle

4. Questions fondamentales à se poser

1. L'atteinte oculaire est-elle ****isolée ou associée**** ?
2. L'atteinte est-elle ****stable ou en évolution**** ?
3. L'enfant est-il ****malvoyant**** ?
4. Une ****correction optique**** est-elle nécessaire ?
5. Existe-t-il un ****retard**** (psychomoteur, intellectuel...) pouvant retentir sur les acquisitions scolaires, lié à la déficience visuelle ?

5. Bilan oculomoteur

- Éliminer un faux strabisme (épicanthus).
- Différencier strabisme manifeste (tropie) et latent (phorie).
- Évaluer : direction, caractère constant/intermittent/alternant/monoculaire, angle de déviation.

****Test d'Hirschberg (reflets cornéens)**** : source lumineuse centrée devant le visage → reflets doivent être centrés ; en cas de strabisme, un reflet est décentré.

Poursuite oculaire

- ****Fixation**** : absente, sporadique, instable ou stable.
- ****Poursuite continue**** : absente, discontinue ou normale.
- ****Poursuite saccadée**** : anormale ou normale.

6. Bilan sensoriel

| Outil | Description |

|---|---|

| ****Regard préférentiel**** | Mesure du pouvoir séparateur (tests de fréquences spatiales) |

| ****PEV (Potentiels Évoqués Visuels)**** | Méthode objective d'évaluation de l'AV |

| ****Réfractométrie / Skiascopie**** | Étude de la réfraction (sous cycloplégie obligatoire) |

| ****Optotypes**** | Mesure de l'AV morphoscopique (possible dès 2,5–3 ans) |

| ****Champ visuel**** | Évaluation du champ nasal et temporal, difficile chez l'enfant |

| ****Stéréoscopie**** | Tests de Wirt/Titmus (qualitatifs), TNO (quantitatif) |

****Signes de perception visuelle : ****

- Directs : localisation d'objets, mouvements vers la cible, poursuite.
- Indirects : réactions posturales, variations respiratoires, sourire, expression du visage.

7. Examens complémentaires

- ****Potentiels Évoqués Visuels (PEV)**** : mesure amplitude/latence d'une réponse électrique à une stimulation visuelle.
- ****Électrorétinogramme (ERG)**** : évaluation de la fonction rétinienne globale.
- ****Électro-oculographie**** : réalisée plus rarement.

8. Aides visuelles

| Aide | Utilisation |

|---|---|

| ****Loupes grossissantes**** (posées ou à main, éclairantes) | Perte légère de vision de près |

| ****Verres filtrants**** | Diminution de l'éblouissement, maintien de l'AV centrale |

| ****Télé-loupes**** (systèmes Galilée ou Kepler) | Vision de loin et de près nécessitant un grossissement important |

| ****Agrandisseurs électroniques**** (caméra + écran, jusqu'à x50) | Lecture de documents, écriture, connexion à un ordinateur |